

Un cistograma es una breve radiografía de su vejiga. La vejiga se llena con suavidad con un medio de contraste especial a través de una sonda para que se vea con claridad en la radiografía. Esto ayuda a su cirujano a comprobar que una reparación ha sanado y es hermética, o a buscar una fuga, una conexión anormal o un reflujo hacia los riñones.

Acerca de esta prueba

Normalmente la vejiga no se ve bien en una radiografía simple. Un cistograma la llena con **medio de contraste** que se ve blanco, para poder comprobar la forma de la vejiga y cómo retiene y libera el líquido. Su cirujano puede pedir un cistograma para:

- Confirmar que una **reparación quirúrgica ha sanado** y no tiene fugas — a menudo antes de retirar una sonda
- Buscar una **fuga** después de una lesión o una cirugía
- Encontrar una conexión anormal (una **fístula**) entre la vejiga y otro órgano
- Comprobar si la orina fluye de regreso hacia los riñones (**reflujo**)

La forma en que entra el contraste depende de su situación:

- Si **no tiene ningún tubo**, se coloca una sonda pequeña solo para la prueba.
- Si ya tiene una **sonda urinaria** o una **sonda suprapúbica**, el contraste suele entrar por ella — no hace falta un tubo nuevo.

¿Es segura?

Sí. Un cistograma es una prueba común y de bajo riesgo. La cantidad de radiación es pequeña, y el contraste a base de agua sale de su cuerpo con la orina. La mayoría de las personas solo sienten llenura o una leve presión. Los efectos secundarios poco frecuentes — una infección urinaria, ardor breve o cólicos — suelen ser leves y pasan rápido.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Cistograma

Una radiografía de la vejiga tomada mientras está llena de contraste.

Vejiga

El saco muscular que almacena la orina hasta que usted orina.

Medio de contraste

Un líquido que se ve blanco en la radiografía para que se pueda ver la vejiga.

Sonda

Un tubo delgado y blando que se usa para llenar la vejiga con contraste.

Sonda suprapúbica

Una sonda que drena la vejiga a través de la parte baja del vientre; el contraste puede entrar por ella.

Fístula

Una conexión anormal entre la vejiga y otro órgano que un cistograma puede revelar.

Reflujo

Orina que fluye hacia atrás desde la vejiga hacia los riñones.

Imágenes de vaciado

Radiografías adicionales que se toman mientras usted orina, cuando es necesario.

¿LE DOLERÁ? La mayoría de las personas solo sienten una sensación de llenura o leve presión a medida que se llena la vejiga, no un dolor agudo. Si se coloca una sonda para la prueba, puede sentir un ardor breve. El equipo puede ir más despacio o detenerse en cualquier momento — solo dígales. La prueba suele durar entre 15 y 30 minutos.

Cómo prepararse (antes de su prueba)

Hay muy poco que hacer para prepararse. En la mayoría de los casos:

- Puede **comer y beber normalmente** y tomar sus **medicinas habituales**, salvo que le indiquen lo contrario.
- Si tiene una sonda o una sonda suprapúbica, **déjela en su lugar** — el contraste a menudo entra por ella.
- Por lo general puede **conducir usted mismo a casa**, porque no se necesita sedación.

Dígale a su equipo **con anticipación** si usted:

- Alguna vez ha tenido una reacción al medio de contraste de las radiografías o al yodo
- Toma un anticoagulante
- Tiene signos de una infección urinaria (ardor, fiebre, u orina turbia con olor fuerte) — una infección activa puede hacer que se re programe la prueba

Qué sucede durante la prueba

- 1 Usted se acuesta en una mesa de radiografía. Si aún no tiene un tubo, se coloca con suavidad una sonda pequeña; si ya tiene uno, se conecta.
- 2 El contraste entra lentamente en la vejiga mientras se toman las radiografías. Es posible que le pidan que se quede quieto y respire normalmente.
- 3 Es posible que le pidan que **orine** para que el equipo pueda tomar imágenes del vaciado de la vejiga (cuando esto forma parte de la prueba).
- 4 Se revisan las imágenes y se retira la sonda — o se deja en su lugar el tubo que ya tenía.

Después de la prueba

- Por lo general puede irse a casa y retomar sus **actividades normales de inmediato**.
- Puede sentir **un ardor leve al orinar** durante un día más o menos. Beber agua adicional ayuda y lo alivia.
- Puede notar un **tono rosado** en la orina por un corto tiempo. Esto es común y suele desaparecer en un día.

Llame al consultorio de su cirujano o busque atención si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Dificultad para orinar, o no puede orinar en absoluto
- Sangrado abundante, o coágulos de sangre en la orina
- Dolor o cólicos en el vientre que empeoran en lugar de mejorar

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Un cistograma es una radiografía rápida y segura que llena la vejiga con un contraste especial — compruebe que una reparación ha sanado o busca una fuga, fístula o reflujo.
2. Hay poco que hacer para prepararse. Deje en su lugar cualquier sonda o sonda suprapúbica, e informe a su equipo sobre cualquier alergia al contraste, anticoagulantes o signos de una infección urinaria.
3. La mayoría de las personas solo sienten llenura y se van a casa de inmediato. Es normal tener un ardor leve o un poco de color rosado en la orina por un día — beba agua adicional, y llame si tiene fiebre, sangrado abundante o dificultad para orinar.